EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86775
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-17 10:40:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN ESTEBAN PENA CUEVAS			**RUN**	: 6.212.060-6
F.Nac	: 10-01-1951	**Edad**	: 73 AÑOS, 5 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: El Coig			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 99956536		
Fecha Ingreso	: 2024-06-07	**Fecha Egreso**	: 2024-06-17 10:40:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I85-VARICES ESOFAGICAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. HDA Variceal
- Anemia Severa secundaria corregida
2. DHC Child Pugh B, Meld Na 12 puntos. Etiología OH
- Hipertensión portal (antec. VE pequeñas)
3. Hiperkalemia severa, resuelta
4. Delirium hipoactivo - Sdme. abstinencia OH, demencia senil
5. Dependencia de alcohol
6. Antecedentes: HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA y DHC por OH Child PugH B; consulta el 06/06/2024 en SU HSC por cuadro de hematemesis de un día de evolución, sin compromiso HD asociado, al examen físico con estigmas de melena. Tiene antecedente de consulta previa el día 03.06.24 por cuadro de CEG y tos productiva, se diagnosticó NAC y se inició tto ATB con amoxicilina/Ac. Clavulánico asociado a paracetamol e ibuprofeno, además se solicitó panel viral ampliado negativo.
Dentro de exámenes de ingreso destaca GGT 221, PCR 13, ELP 137/6.6/107, Hb 10.5, Hto 31.1, TP 63%, INR 1.37.
Se iniciaron medidas hipokalemiantes de forma parcial sin respuesta de laboratorio. Se presenta a residente UTI y se decide ingreso a unidad para manejo médico de hemorragia digestiva y de hiperkalemia severa.
Paciente evoluciona con hemodinamia autosostenida, sin requerimiento de DVA, el 08/06/2024 presenta caída importante de Hb hasta 7.0 por lo que se transfunde 1 U GR. Desde el 09/06 con tendencia a la hipertensión sistólica por lo que el 10/06 se reinicia tratamiento antihipertensivo. Ventilando espontáneo, sin requerimiento de FiO2 adicional. En tratamiento con Ceftriaxona como profilaxis de PBE, completa 5 días; por antecedente de Neumonía en tratamiento a su ingreso y aumento de tos ahora productiva, se decide mantener antibioticoterapia, se solicita CSB y Rx de Tórax de control (RxTx del 03.06 sin foco claro de condensación). Función renal conservada, actualmente con hiponatremia e hipokalemia en corrección. Metabolicamente estable, reinicia regimen liquido progresivo a tolerancia, sin embargo, por tendencia a la somnolencia no se ha logrado alimentar de forma efectiva. En tratamiento por delirio hiporeactivo y síndrome de abstinencia con bzd, se decide suspender por baja estado de alerta. Se realiza EDA : Varices esofágicas de gran tamaño con indicadores de riesgo de sangrado. Se procede a realizar

ligaduras con bandas elásticas para un total de 6, sin complicaciones inmediatas. Completando tratamiento con terlipresina, hoy quinto dia, por hiponatremia persistente, se decide suspender. Paciente estable, en condiciones de traslado a Servicio de Medicina, pendiente progresar regimen via oral, evaluar evolución de cuadro respiratorio.
En medicina persiste con tos, pero con parámetros inflamatorios a la baja, actualmente sin requerimiento de oxígeno, sin signos de sangrado activo, por lo que se decide continuar manejo por HODOM para kinesioterapia respiratoria.

PLAN DE MANEJO:

Control por medicina dentro de 10 días.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen blando bajo en sal
3. Omeprazol 20mg 1 c 12hrs por 15 días
4. Enalapril 10mg 1 c 12hrs vo
5. Espironolactona 25mg 1 c 12hrs vo
6. Propanolol 10mg 1 c dia vo
7. Lactulosa 10ml junto con cada comida para tener 2 a 3 deposiciones diarias
8. Bromuro de ipratropio 2 puff c 6hrs por 10 días
9. Prednisona 20mg 1 c 12hrs dia por 4 días
10. Kinesioterapia respiratoria

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO